EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90171
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-07 12:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: REINERIO LABRA RODRIGUEZ			RUN	: 9.331.101-9
F.Nac	: 08-02-1962	Edad	: 62 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: OSCAR OLAVE 1326 VILLA LOS REGIDORES			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-04	Fecha Egreso	: 2024-08-07 12:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico obs precentral izquierdo, etiología ATE intracraneana
-Ant: HTA - DM2 - Retinopatía diabética bilateral - TBQ activo (20/d)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

BEG, HDN estable, RS al monitor, afebril, eupneico, tranquilo, hiperglicemia vespertina, sin dolor, estable en déficit neurológico respecto al lunes, tolera bien alimentación VO, marcha con leve inestabilidad.
Describe evento: el sábado en la noche presentó disartria autolimitada (20 min), el domingo en la mañana al despertar percibe disartria leve y paresia ESD M4; consultó en SU HSC, se hospitalizó, aprox a las 20h de ayer sufrió mayor pérdida de fuerza en ESD que mantiene hasta hoy. Niega síntomas constitucionales o cardiorrespiratorios asociado al evento actual (solo cefalea frontal leve aislada).
AngioTC cerebro y cuello sin lesiones agudas, se observa infartos crónicos de aspecto lacunar en putamen, occipital y lateral a asta temporal izquierdos y en corona radiada derecha posterior, microangiopatía Fazekas 2; estenosis origen M2 anterosuperior y P2 izquierdos >50% y placa blanda sin estenosis significativa en bulbo carotideo derecho.
TC cerebro s/c de control sin lesiones agudas evidentes. Sin RAM por DAPT.
Diuresis(+), dep(-)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, ETT y Holter ambulatorios, continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica por HODOM, TC cerebro s/c de control en 5-7 días, y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-ETT y Holter ambulatorios
-DAPT por 90 días
-Continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica por HODOM
-TC cerebro s/c de control en 5-7 días
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Clopidogrel 75 mg/día
3. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche

4. -Famotidina 40 mg/día
5. -Losartan 50 mg 1/2 comp al día
6. -Insulina NPH 14 U AM

EXÁMENES Y RESULTADOS

5/8/24
-Crea 1.2 MDRD 61.35 Uremia 50
-Ca 9.7
-ColT 102 HDL 39 LDL 43 VLDL 19.6 TG 98
-PCR <5
-Na 137 K 5.2 Cl 107
-Leu 10800 Hb 16 Plaq 298000 Seg 75
-INR 1.05 TTPA 32
-TSH 1.154 T4L 1.03
-B12 391
-Procal 0.06
-RPR N/R
-Hb glic 11.1

4/8/24
-OC N
-Crea 1 MDRD 75.72 Uremia 54
-FA 137 BI 0.49 BD 0.11 BT 0.6 GOT 26 GPT 30 GGT 14
-CKMB 28 CK 60
-LDH 151
-PCR <5
-Na 137 K 6 Cl 104
-Leu 10000 Hb 15.7 Plaq 292000 Seg 77
-INR 1.06 TTPA 31
-Trop 3.5

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-), arterias temporales N
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: conservado
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, disartria leve, nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: ESD M4(-)flexión de dedos y resto proximal y distal M4-M4(+), EID M5, BC izq M5, RCP extensor derecho
-Sensibilidad: conservado
-Cerebelo: conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO